

1 実践チェックリスト(保険薬局/病院)

保険薬局薬剤師	病院薬剤師
☐ 保湿剤の量・回数・塗り方を実演で説明 ☐ 外用ステロイドの部位別の使い分けを確認 ☐ 保湿剤・外用薬の残量から使用状況を把握 ☐ 胃薬・サプリなど他院処方・市販薬の相互作用確認 ☐ 悪化や生活への支障をトレーシングレポートで病院へ	☐ 予防内服・保湿剤・外用薬の処方セットの提案 ☐ Grade評価と休薬・減量・皮膚科紹介の判断支援 ☐ 抗EGFR抗体投与時の皮膚症状・Mg値の確認 ☐ 重症薬疹・ICIの皮膚障害への院内対応 ☐ お薬手帳へのレジメン・開始日の記載
病院と共有する情報	レジメン・開始日
皮膚症状のGrade・経過	外用薬の使用状況
予防内服の服用状況	

2 予防と治療 — 皮膚障害の型で使い分ける

皮膚障害	予防(治療開始時から)	症状が出た時	薬剤師の確認ポイント
ざ瘡様皮疹 (EGFR阻害薬)	保湿・日焼け止め、テトラサイクリン系の予防内服	部位に応じた強さの外用ステロイド	予防内服の服用状況、ミノサイクリンのめまい・色素沈着
爪囲炎	深爪を避け、爪の周りへの刺激を減らす	外用ステロイド、テーピング、皮膚科での処置	痛み・歩行への影響、皮膚科受診の要否
手足症候群	保湿剤、圧迫・摩擦・熱を避ける、厚い角質の事前ケア	強めの外用ステロイド、休薬・減量	保湿の回数(1日2回以上)、靴・家事の工夫
皮膚乾燥・亀裂	入浴後すぐの保湿	亀裂にはワセリン等で保護	亀裂・びらん尿素製剤は刺激になるため見直し
ICIの皮疹・かゆみ	保湿	外用ステロイド・抗ヒスタミン薬	粘膜症状・水疱は重症薬疹を疑い即受診

3 相互作用・併用注意(他院処方・市販薬・サプリを含む)

重要度	薬剤(機序)	相手の薬(区分)	起こること	薬局での対応
注意	ゲフィチニブ・エルロチニブ 胃内pH上昇で吸収低下	処方薬 市販薬 PPI・H2ブロッカー	血中濃度↓ → 効果減弱	市販の胃薬も含めて確認
注意	エルロチニブ CYP1A2誘導	生活習慣 喫煙	血中濃度↓	喫煙状況を確認し禁煙を支援
注意	ミノサイクリン(皮疹の予防内服) キレート形成	処方薬 市販薬 サプリ・食品 鉄剤・制酸剤・カルシウム	吸収↓ → 予防効果の減弱	服用時間をずらすよう指導
注意	カペシタビン ワルファリンの代謝を阻害	処方薬 ワルファリン	PT-INR↑ → 出血	他院処方を確認し、INRの測定を処方医と共有
注意	レゴラフェニブ・ソラフェニブ等 CYP3A4誘導	サプリ・食品 セイヨウオトギリソウ	血中濃度↓ → 効果減弱	サプリメントの使用を確認
確認	EGFR阻害薬・カペシタビン等 刺激で悪化	生活習慣 直射日光・きつい靴・熱いお湯	皮疹・手足症候群の悪化	日焼け止め・靴・手袋など生活の工夫を指導

4 服薬指導の声かけ例と確認のタイミング

治療開始前	開始～2週	1～2か月	随時
「皮膚の症状は、予防のスキンケアを早く始めるほど軽くすみませう。今日から保湿を習慣にしましょう」 確認:お薬手帳でレジメン、予防内服・保湿剤・外用薬の処方と量 △ 保湿剤の量と回数を実演で説明	「顔や胸にニキビのような発疹が出て、自己判断で薬をやめず、塗り薬を使ってください」 確認:皮疹・手足の発赤の有無、外用ステロイドの部位別の使い分け △ 足の裏の痛みで歩きにくい時は連絡	「爪の周りの腫れや痛み、手足のひび割れはありませんか」 確認:爪囲炎・乾燥・亀裂、保湿剤・外用薬の残量から使用状況を把握 △ 亀裂への尿素製剤は刺激になるため見直し	「熱を伴う発疹や、目の充血・口のただれがあれば、すぐに連絡してください」 確認:新たに始めた薬(他院処方・市販薬)の有無 △ 粘膜症状・水疱は重症薬疹を疑い即受診